CONTOH PROMPT KODING RAWAT INAP

1. EFUSI PLEURA

PROMT : Analisis ketepatan koding diagnosis EFUSI PLEURA pada dokumen klaim rawat inap (Resume Medis) agar sesuai dengan berita acara kesepakatan klaim dan untuk mengetahui penunjang & tata laksana diagnosisnya

Sumber : BA Kesepakatan klaim tahun 2019
Efusi pleura sebagai diagnosis sekunder apabila memenuhi salah satu Kriteria berikut ini:

1. Efusi pleura dengan jumlah berapapun dan penyebabnya apapun yang terbukti terdapat cairan dengan tindakan pungsi pleura/ thorakosintesis
2. Efusi pleura yang terbukti dengan pemeriksaan imaging (foto toraks dan/ atau USG toraks dan/ atau CT Scan toraks) dengan jumlah minimal atau lebih dari minimal yang disertai dengan tindakan punksi pleura (tidak harus keluar cairan) dan / atau tatalaksana tambahan sesuai penyebabnya diluar tatalaksana diagnosis primer.

Definisi efusi pleura dengan jumlah minimal bila memenuhi salah satu kriteria berikut :

1. Gambaran efusi pada foto toraks lateral decubitus dan/ atau CT Scan toraks dengan ketebalan kurang dari 10 mm.
2. Gambaran efusi pada USG toraks dengan jumlah cairan kurang dari 100 ml dan/atau jarak antara pleura parietal dan pleura viseral kurang dari 10 mm.

HASIL :

- Efusi pleura ditemukan hasil foto thorak dg Kesimpulan.....
- Pada billing sudah terdapat analisis cairan pleura/pungsi pleura
- terdapat terapi EFUSI pleura.....

2. SEPSIS

- **PROMPT**: Analisis ketepatan koding diagnosis Sepsis pada dokumen klaim agar sesuai dengan aturan Berita acara kesepakatan klaim dan untuk mengetahui penunjang dan tata laksana diagnosisnya
- **Sumber Data**: Berita Acara Kesepakatan Klaim Tahun 2019

Penegakan diagnosis sepsis dapat mengikuti kriteria SIRS (systemic inflamatory response syndrome) yaitu terdiri dari minimal 2 keadaan:

1. Temperatur >38,5 derajat celcius atau 36 derajat celcius
2. Denyut Jantung >90 x/menit
3. Frekuensi pernafasan >20x/menit atau PaCO2 <32 mmHg (Pada pemeriksaan AGDA)
4. Terdapat respons tubuh terhadap fokal infeksi, peradangan, dan stres dengan hasil laboratorium menunjukkan leukositosis dan wajib melampirkan bukti kultur darah dengan hasil bakterimia.

Apabila diagnosis sepsis dapat ditegakkan maka harus diikuti dengan tata laksana sepsis.

- **Hasil:**

Sepsis dapat ditemukan dari hasil lab mikrobiologi

Sepsis dapat ditemukan dari hasil lab darah dengan pemeriksaan leukositosis yang tinggi

Terdapat terapi/tata laksana sepsis

3. PNEUMONIA

- **PROMPT**: Analisis ketepatan koding diagnosis Pneumonia pada berkas klaim untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan Berita Acara Kesepakatan Klaim, serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tata laksana terapi yang diberikan
- **Sumber Data**: Berita Acara Kesepakatan Klaim Tahun 2019

Pneumonia dapat didiagnosis sesuai dengan KMK RI No. HK. 02.02/MENKES/514/2015 yaitu jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala dibawah ini :

1. Batuk-batuk bertambah
2. Perubahan karakteristik dahak / purulen
3. Suhu tubuh > 38°C (aksila) / riwayat demam
4. Pemeriksaan fisik : ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki
5. Leukosit > 10.000 atau < 4500

- **Hasil**:

Pneumonia dapat ditemukan pada hasil foto thorax, CT Scan, MRI
Terdapat minimal 2 gejala yang tertulis di Resume Medis

Pada pasien dewasa ada hasil lab mikrobilogi dengan hasil bakterimia

Terdapat terapi/tata laksana Pneumonia

4. RESPIRATORY FAILURE (GAGAL NAFAS) AKUT

- **PROMPT**: Analisis ketepatan koding diagnosis Gagal Napas Akut (J96.0) pada berkas klaim sesuai Berita Acara Kesepakatan Klaim, mencakup verifikasi dokumentasi penunjang dan evaluasi tata laksana terapi
- **Sumber Data**: Berita Acara Kesepakatan Klaim Tahun 2019

  Kriteria gagal napas akut (acute respiratory failure) (J96.0) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

  1. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pO2 < 60 mmHg dan / atau SaO2 < 91%
  2. Hasil pemeriksaan pulse oksimetri menunjukkan SpO2 < 91%
  3. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pO2 / FIO2 (P/F) ratio < 300
  4. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pCO2 > 50 mmHg dengan pH < 7,35
  5. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan pCO2 ≥ 10 mmHg dari nilai dasar (bila diketahu hasil analisis gas darah sebelumnya)

  Tatalaksana salah satu dibawah ini :

  1. Terapi oksigen dengan :
     - Low flow: nasal kanul, masker simple, rebreathing mask, non-rebreathing mask
     - High flow: venturi mask, high flow nasal kanul
  2. Ventilasi non invasif: CPAP, BiPAP
  3. Ventilasi invasive (ventilator)
- **Hasil:**

  Gagal nafas akut dapat ditemukan dari hasil pemeriksaan lab darah BGA

  Terdapat terapi/tata laksana Gagal Nafas Akut

5. RESPIRATORY FAILURE (GAGAL NAFAS) KRONIS

- **PROMPT**: Analisis ketepatan koding diagnosis Gagal Napas Kronis (J96.1) pada berkas klaim sesuai Berita Acara Kesepakatan Klaim, mencakup verifikasi dokumentasi penunjang dan evaluasi tata laksana terapi
- **Sumber Data**: Berita Acara Kesepakatan Klaim Tahun 2019
  Kriteria gagal napas kronik (chronic respiratory failure) (J96.1) apabila memenuhi kriteria berikut ini:
  Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan seluruh kriteria berikut:
  a. peningkatan $pCO_2 > 50$ mmHg
  b. peningkatan bikarbonat (HCO_3) > 24 mmHg
  c. pH normal (7,35 – 7,45) d. $pO_2 < 60$ mmHg dan / atau $SaO_2 < 91\%$
  Tatalaksana salah satu dibawah ini :
  1. Terapi oksigen dengan :
     • Low flow: nasal kanul, masker simple, rebreathing mask, non-rebreathing mask
     • High flow: venturi mask, high flow nasal kanul
  2. Ventilasi non invasif: CPAP, BiPAP
  3. Ventilasi invasive (ventilator)
- **Hasil**:
  Gagal nafas kronis dapat ditemukan dari hasil pemeriksaan lab darah BGA
  Terdapat terapi/tata laksana Gagal Nafas Kronis

6. PROSEDUR TINDAKAN OPERASI

- **PROMPT**: Analisis ketepatan koding prosedur tindakan operasi pada laporan operasi sesuai isian laporan operasi mencakup kolom no.6 (Deskripsi/Uraian Operasi (procedure performed and description)) dan kolom no.7 (Apa yang dikerjakan, Nama Operasi (Name of Operation))
- **Sumber Data**: Laporan Operasi
  - Melihat deskripsi nama tindakan (kolom No.6 → Deskripsi/Uraian Operasi (procedure performed and description)
  - Memastikan kembali apakah nama tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang tertulis di kolom No. 6 dan No.7
  - Pastikan Kode prosedur tindakan operasi yang sesuai dengan nama tindakan di kolom no.6 dan no.7
  - Pastikan apakah ada diagnosis yang ditemukan saat operasi dilakukan
- **Hasil**:

  Koding prosedur tindakan operasi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Dokter Operator
  Adanya tambahan diagnosis yang ditemukan saat operasi

7. INFARK CEREBRI

- **Prompt**:

Analisis ketepatan kode I63.- pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim

- **Sumber data:**

Hasil imaging (CT scan) diperhatikan untuk penegakan tambahan jenis Stroke hemorrhagic atau non hemorrhagic.
I63.- jika hasil pemeriksaan CT Scan (+) infark.

- **Hasil:**

Ditemukan infarksi pada hasil CT Scan yang menunjang penggunaan kode I63.-

8. ABSES HATI

- **Prompt**:

Analisis ketepatan kode K75.0 pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim

- **Sumber data:**

Ada hasil USG/ Ct scan yang menyatakan kesimpulannya : Abses Hati

- **Hasil:**

Terdapat bacaan abses hati pada hasil USG/CT Scan yang menunjang penggunaan kode K75.0

9. ANEMIA

- **Prompt:**

Analisis ketepatan kode D64.9 pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim

- **Sumber data:**

a. Anemia sebagai diagnosis sekunder adalah anemia yang disebabkan oleh : Komplikasi penyakit utamanya (dimana terapi anemia berbeda dengan terapi utamanya), contoh : pasien kanker payudara yg diradioterapi, pada perjalanannnya timbul anemia maka anemia tersebut dapat dimasukkan diagnosa sekunder dan stadium lanjut, dll) yang memerlukan transfusi darah dan eritropoetin harus dimasukkan .

b. Anemia gravis (Hb < 8) pada penyakit kronik (contoh : gagal ginjal kronik, kanker, dll) ke dalam diagnosis sekunder karena memerlukan pengobatan khusus yg berbeda dari penyakit dasarnya.

c. Mendapatkan Terapi berupa Transfusi darah

- **Hasil:**

Anemia dengan Hb<8 dan mendapatkan terapi berupa transfuse darah

10. ASCITES

- **Prompt:**

Analisis ketepatan kode R18 pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim

- **Sumber data:**

Kriteria Rawat Inap untuk Ascites adalah Ascites masif, tujuan tindakan Pungsi untuk Terapeutik.

- **Hasil:**

Terdapat Tindakan pungsi untuk mendukung penggunaan kode R18

11. HYPOKALEMIA

- **Prompt:**

Analisis ketepatan kode E87.6 pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim

- **Sumber data:**

- harus ada hasil Kalium <3.00
- Mendapat terapi injeksi KCL

- **Hasil:**

Nilai Kalium pasien <3.00 dan mendapatkan terapi injeksi KCL yang mendukung penggunaan kode E87.6

CONTOH PROMPT KODING RAWAT JALAN

1. D56 BETA THALLASEMIA

Prompt: Analisis ketepatan koding diagnosis Beta Thallasemia (D56) pada berkas klaim sesuai berita acara kesepakatan klaim, mencakup verifikasi dokumen penunjang

Sumber Data : Berita Acara Kesepakatan Klaim INA-CBG Tahun 2019

- Jika pasien dengan Thalasemia Mayor pada saat kontrol ulang diberikan obat kelasi besi (Deferipone, Deferoksamin, dan Deferasirox) maka diinputkan sebagai rawat jalan dengan menggunakan kode D56.1 sebagai diagnosis Utama
- Sebagai kelengkapan berkas top up INA-CBG harus dilampirkan product batch obat (protokol pemberian kelasi besi)
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 bahwa pengajuan klaim pada pelayanan thalasemia mayor baik rawat jalan atau rawat inap yang menerima terapi kelasi besi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan.

Hasil:

Kode D56.1 digunakan sebagai diagnosis utama dan dilakukan top up *special drugs* ketika pasien diberikan obat kelasi besi yang didukung oleh dokumen penunjang protocol pemberian kelasi besi dan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan

2. Z51.1 CHEMOTHERAPY SESSION FOR NEOPLASM

Prompt: Analisis ketepatan koding diagnosis Z51.1 sebagai diagnosis utama sesuai Permenkes No 26 Tahun 2021 mencakup verifikasi dokumen penunjang

Sumber Data : Permenkes No 26 Tahun 2021

- Pasien yang datang ke rawat jalan dan mendapatkan obat kemoterapi oral, maka menggunakan kode Z51.1 (Chemotherapy Session for Neoplasm) sebagai diagnosis utama dan kode neoplasma tidak dikode sebagai diagnosis sekunder.
- Pasien yang datang ke rawat jalan atau rawat inap dan mendapatkan kemoterapi injeksi, maka menggunakan kode Z51.1 (Chemotherapy Session for Neoplasm) sebagai diagnosis utama dan kode neoplasma sebagai diagnosis sekunder.
- Kunjungan untuk kemoterapi harus dilengkapi dengan dokumen penunjang Laporan Kemoterapi
- **Hasil:**

Koding diagnosis utama kemoterapi Z51.1 sebagai diagnosis utama pada pasien yang diberikan kemoterapi dilengkapi dengan dokumen penunjang laporan kemoterapi

3. Z09.0 FOLLOW-UP EXAMINATION AFTER SURGERY FOR OTHER CONDITIONS

Prompt: Analisis ketepatan koding diagnosis control Z09.0 sebagai diagnosis utama sesuai resume medis dan billing kunjungan pasien rawat jalan

Sumber Data : Permenkes No 26 Tahun 2021, Resume medis, Billing

- Pasien yang datang untuk kontrol ulang di rawat jalan dengan diagnosis yang sama pada kunjungan sebelumnya, ditetapkan sebagai diagnosis utama menggunakan kode “Z” dan diagnosis sekunder dikode sesuai penyakitnya.
- Pasien bukan control ulang untuk kondisi Neoplasm
- Pasien bukan bayi usia kurang dari 7 (tujuh) hari datang untuk kontrol ulang
- Pasien post operasi tanpa dilakukan angkat jahitan
- Pasien tidak dilakukan tindakan operatif ODC
- Pasien diberikan terapi/tata laksana selain assesmen dan konsultasi sesuai yang tertera dalam billing

Hasil:

Koding diagnosis control Z09.0 sebagai diagnosis utama sesuai dengan kondisi pasien dan tatalaksana yang diberikan

ENDOSCOPY

Prompt: Analisis regio prosedur endoscopy yang dilakukan, tentukan kode endoscopy yang sesuai dengan regio yang dilakukan

Sumber Data : Utilization Review Agustus 2026

- Prosedur endoscopy pada hidung gunakan kode 21.21
- Prosedur endoscopy pada sinus gunakan kode 22.19

Hasil:

Koding endoscopy yang dilakukan pada hidung menggunakan 21.21 sedangkan pada sinus menggunakan 22.19

HEART FAILURE DENGAN HIPERTENSI

Prompt: Analisis penggunaan kode I50.- disertai dengan kondisi hipertensi I10

Sumber Data : ICD 10

- Exclude: Heart failure disertai dengan hipertensi menggunakan I11.0

Hasil:

Koding I11.0 digunakan sebagai kondisi heart failure disertai dengan hipertensi

REHABILITASI

Prompt: Analisis apakah dilakukan prosedur rehabilitasi pada kunjungan sekarang, serta tentukan kode diagnosis utama pasien sesuai dengan keperluan rehabilitasi pada kode Z50.-

Sumber Data : ICD 10

- kode Z50.0 sebagai kondisi pasien perlu untuk dilakukan prosedur terkait rehabilitasi terkait cardiac
- kode Z50.1 sebagai kondisi pasien perlu untuk dilakukan prosedur terkait rehabilitasi terapi fisik
- Kode Z50.5 sebagai kondisi pasien perlu untuk dilakukan prosedur terkait rehabilitasi terapi wicara/verbal
- Kode Z50.7 sebagai kondisi pasien perlu untuk dilakukan prosedur okupasi

Hasil:

Koding diagnosis rehabilitasi Z50.- sebagai diagnosis utama sesuai dengan kondisi pasien dan tatalaksana yang diberikan

ANEMIA

Prompt: Analisis penggunaan kode diagnosis untuk anemia sesuai dengan kondisi penyerta pasien

Sumber Data : ICD 10

- kode D62 sebagai kondisi anemia yang diakibatkan oleh perdarahan
- kode D63.0 sebagai kondisi anemia pada kasus neoplasm
- kode D63.8 sebagai kondisi anemia pada kasus kronis dengan contoh pada pasien kasus CKD

Hasil:

- Koding diagnosis D62 sebagai diagnosis anemia sesuai kondisi penyerta pasien
- Koding diagnosis D63.0 sebagai diagnosis anemia sesuai kondisi penyerta pasien
- Koding diagnosis D63.8 sebagai diagnosis anemia sesuai kondisi penyerta pasien

PNEUMONIA DAN EFUSI PLEURA PADA TB PARU

Prompt: Analisis koding pneumonia (J15.- ; J18.-) dan efusi pleura (J90) apakah merupakan penyerta pada kasus TB paru

Sumber Data : ICD 10

- Note pada A16 menunjukkan bahwa pneumonia serta efusi pleura include pada kodefikasi TB paru

Hasil:

Koding diagnosis A16.- tanpa menyertakan kode pneumonia dan efusi pleura

KELOID

Prompt: Analisis terkait diagnosis keloid, apakah keloid merupakan kondisi yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh atau hanya sebagai tujuan estetika

Sumber Data : Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 52 ayat 1 furuf f

- Sesuai perpres pelayanan kesehatan dengan tujuan estetika tidak dijamin

Hasil:

Kode L91.0 dihapus karena hanya merupakan tujuan estetika

MRI

Prompt: Analisis regio penggunaan MRI dilakukan pada mana dan sesuaikan dengan lokasi diagnosis yang ada

Sumber Data : ICD-9-CM

- Kode prosedur 88.91 untuk MRI yang dilakukan pada bagian otak
- Kode prosedur 88.92 untuk MRI yang dilakukan pada bagian dada dan otot jantung
- kode prosedur 88.93 untuk MRI yang dilakukan pada bagian tulang belakang
- kode prosedur 88.94 untuk MRI yang dilakukan pada bagian muskuloskeletal berupa ekstremitas serta bone marrow blood supply
- kode prosedur 88.95 untuk MRI pada bagian pelvis, prostat dan bladder

Hasil:

- Kode prosedur MRI yang digunakan 88.91 sesuai regio yang dilakukan
- Kode prosedur MRI yang digunakan 88.92 sesuai regio yang dilakukan
- Kode prosedur MRI yang digunakan 88.93 sesuai regio yang dilakukan
- Kode prosedur MRI yang digunakan 88.94 sesuai regio yang dilakukan
- Kode prosedur MRI yang digunakan 88.95 sesuai regio yang dilakukan

Prompt:

Sumber Data :

Hasil: